Neuro病房Orientation

2026.03

每日任務清單

- 上班時間：0800AM-1700PM
  - 白班處理complaints：0800AM前值班；0800AM後當科
  - 小夜接New Pa：1600PM前當科，1600PM後值班
  - 小夜處理complaints： 1700PM前當科，1700PM後值班
  - NSP team：8:00-16:00班的NSP，**15:00**後new patient由值班醫師接
8:30-16:30班的NSP，**15:30**後new patient由值班醫師接
- 假日值班時間：0800AM-0800AM
- 日間有New patient時，由CR分配新病人，以護理師電話通知為準
  - 日間New Pa太多或同時入病房時，CR可依實際狀況調整接Pa人力

每日任務清單

- 每日第一件事:
  先轉夜間新病人的service



2025/8/25	CR	黃冠毓	VS		張健宏				來源備註：[普] 普通病房轉 ICU：[		0 : ascul
日期	病床號	姓名	年齡	性別	病歷號碼	病房主治	門診主治	來源			夜
2025/8/25	L09H0949		86	F	20013257	蘇筱筑	X	急	Acute onset right side weakness with slurry NIHSS:20, MRS:5 s/p IA thrombectomy with		日
2025/8/25	L13H1319A		70	F	2916146	林宜穎	X	急	Hyperglycemic generalized chorea, R>L		日
2025/8/25	L11G1127B		32	F	22582353	廖庭偉	吳禹利	門	1st ever convulsion on awakening on 2025/7/22, for vEEG	E	日
2025/8/25	L11G1117B		73	F	39103201	吳逸如	X	I	Right MCA M1 occlusion with right hemisphere infarction, NIHSS 7, onset: 2025/08/23 night, last normal time: 2025/08/23 19:00, s/p IVtPA 0.9mg/kg, s/p EVT TICI = 3, mRS 4	V	日
2025/8/25	L11G1127A		42	M	39142128	張宏旭	X	I	Brainstem ICH 4ml ICH score: 2	V	日
2025/8/25	L13H1320A		57	M	21170847	張庭瑜	張健宏	門	Right ICA occlusion at paraclinoid ICA, RT V4 near occlusion, f/u DSA for Credo stent	V	夜
2025/8/25	L13H1312B		47	M	20930568	吳秀娟	張健宏	門	Right MCA stenosis, admission for DSA	V	夜
2025/8/25	L11G1101C		61	M	4815470	徐文俊	X	急	consciousness disturbance, suspected right lacunar infraction, r/o meningitis, r/o Wernicke encephalopathy	I	夜
2025/8/25	L11G1106A		63	M	3147223	張宏旭	X	急	1. Acute binocular vertical diplopia, onset: 8/22, improving, 2. Right Pcom infundibulum dilatation	V	夜
2025/8/25	L11G1122B		84	M	39106633	吳秀娟	吳秀娟	急	Acute onset of dizziness, r/o right cerebellar infarction	V	夜
2025/8/25	L11G1126A		58	F	903478	江星逸	鄭美雲	急	Acute progressive right eye blurred vision, r/o recurrent optic neuritis, r/o recurrent Susac syndrome, r/o CNS demyelinating disease	M	夜

每日任務清單

- 每日第一件事：先轉夜間新病人的service
- 每日第二件事：Morning meeting
  - 地點：9H加護病房外之討論室
    （門牌：神經外科會議室）
  - 時間：8:15/8:30～9:00

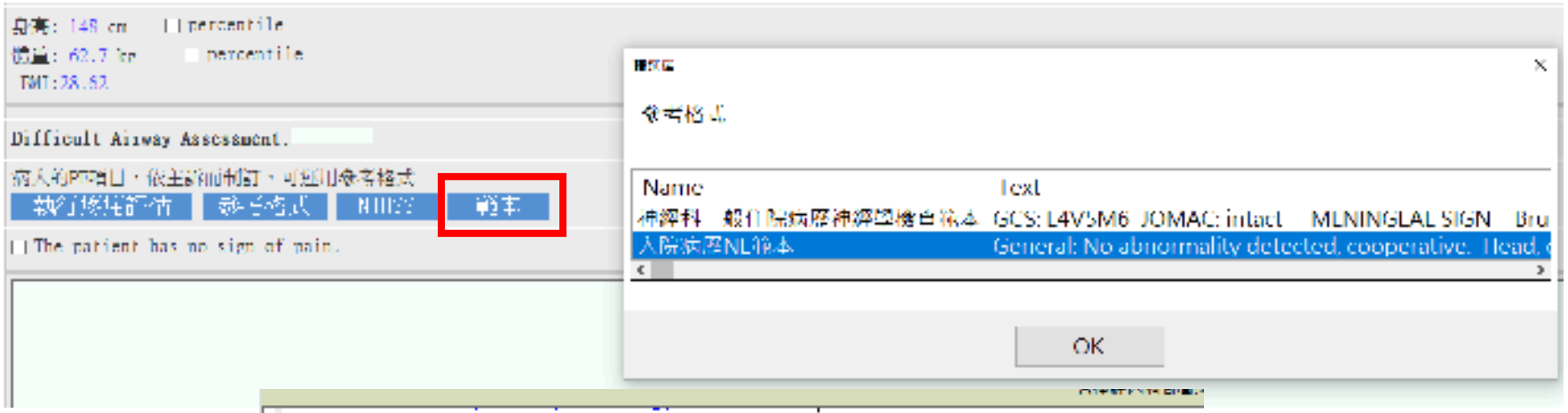


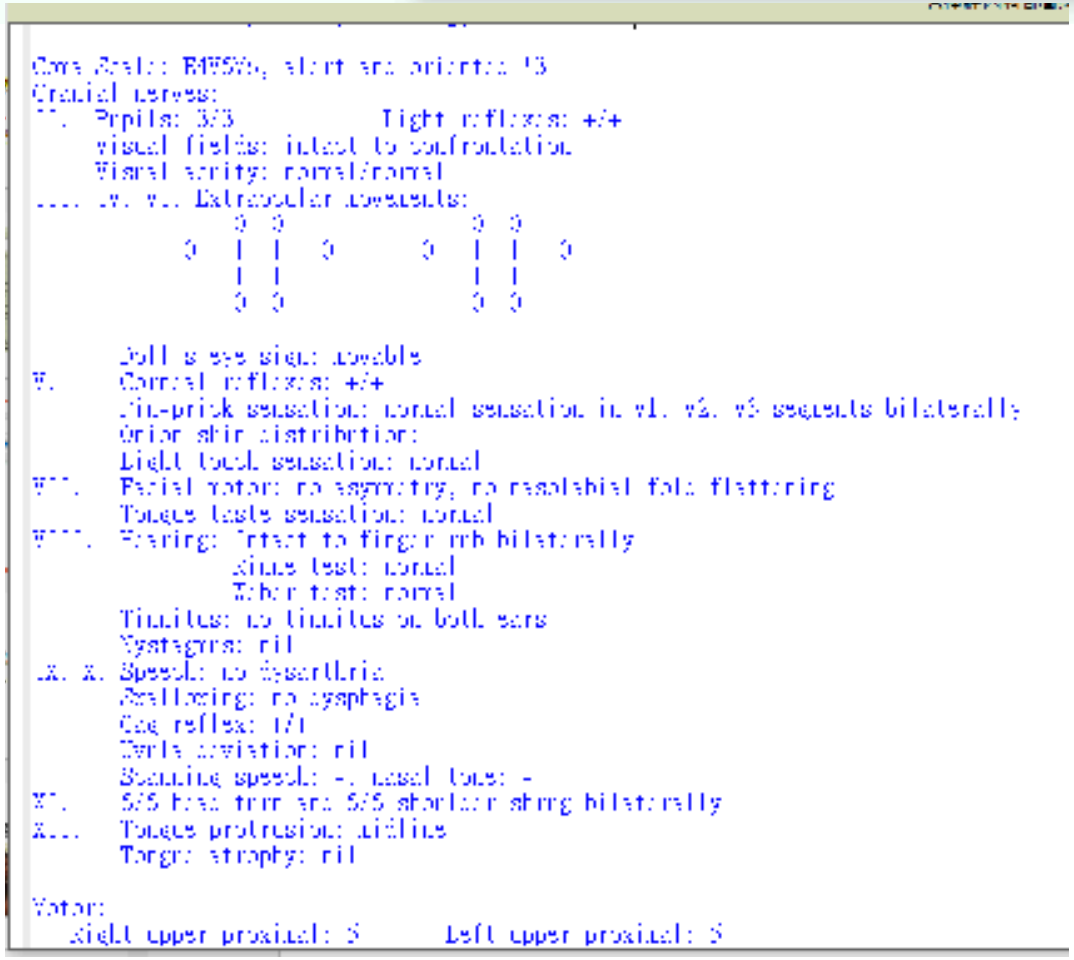
每日任務清單



- 關於打病歷那些事...
  - Admission Note：於入院當日完成，
    務必具備完整NE
    Ischemic stroke病患需紀錄NIHSS和mRS；
    ICH病患需紀錄ICH score
  - 每日Progress Note：務必紀載NE
  - 週五Weekly summary：**務必紀載NE**
    若是周五day off或特休請提早寫，勿留給cover的人
  - 病人轉至它科或ICU時，務必完成 **Transfer Note**
    病人由科外或ICU轉入時，請完成Acceptance Note或On service Note
  - 腰椎穿刺、中央靜脈導管、氣管內管、肌肉切片、神經切片
    =>請留Procedure Note


請選擇
請選擇一個項目
科範本
個人範本
他科範本
請選擇一個項目
A神經內科部範本
A神經內科部範本:ICU
B IV-tPA
B Post-IA
B Post-IV-tPA
B失智症科範本
B神經肌肉科範本
B動作障礙科範本
B腦血管科範本
B癲癇科範本
Amphotericin B
Autoimmune Profile
OK
關閉


Difficult Airway Assessment.
The patient has no sign of pain.
Name
Text
GCS: E4V5M6 JOMAC: intact
MLNINGEAL SIGN
General: No abnormality detected, cooperative.
OK


Cranial nerves:
Pupils: 3/3 Light reflexes: +/+
Visual fields: intact to confrontation
Visual acuity: normal/normal
Extraocular movements:
Doll's eye sign: movable
Corneal reflexes: +/+
Facial motor: no asymmetry, no nasolabial fold flattening
Taste: taste sensation: normal
Hearing: react to finger rub bilaterally
Rinne test: normal
Weber test: normal
Tinnitus: no tinnitus on both ears
Nystagmus: nil
Speech: no dysarthria
Swallowing: no dysphagia
Gag reflex: +/+
Uvula deviation: nil
Shoulder shrug: 5/5 bilaterally
Tongue protrusion: midline
Motor:
Right upper proximal: 5 Left upper proximal: 5

每日任務清單

- 關於接New Pa那些事...
  - 由CR分配病人；夜間住院病人由CR隔天早上分配病人
  - CR可依實際狀況調整接Pa人力，儘量讓大家白天接Pa平均(但無法保證)
  - 分配原則:
    VS自己病人 > 65歲以上優先給老醫 > 同次專科病人 > 平均分配病人

- New Case round
  - 請務必參加自己所屬的次專科meeting
  - 口頭報告前一週入院病人病史/NE/診斷

- 其餘學術活動參考Weekly Activity

神經內科部科會	QW2 16:30	9H 會議室
Neuromuscular Team	QW3 15:00	9H 會議室
Stroke Team	QW3 13:45 9H 會議室	
Epilepsy Team	QW4 11:30	9H 會議室
Movement Team	QW4 16:00	9H 會議室
Dementia Team	QW4 14:30	9H 會議室



每日任務清單

- 關於檢查的那些事……
  - 神經科檢查代碼：M29-開頭。
  - 如屬於神經症急症(Cluster seizure, Gullain-Barre syndrome, Basilar artery occlusion)，開立檢查後請聯絡檢查室登記on call

簡稱	代碼	項目名稱	
TCD	M29-079	Dopscan & B-mode real time sonography	**俗稱頸超** **兩張一起開**
CCD	M29-088	Color-coded transcranial ultrasonography	**半年內有做過可先不開**
BAEP	S48-031-8	B.S.R	
SSEP	M29-026	Evoked potential S.E.P. hand	**俗稱EP，記得問老闆要開啥** SSEP = Sensory MEP = Motor VEP = Visual BAEP/VEMP = brainstem
	M29-027	Evoked potential S.E.P. leg	
VEP	M29-028	Evoked potential V.E.P.	
MEP	M29-038	M.E.P (upper limbs)	病人放過支架或腦部有植入物(DBS, Shunt)不可做MEP
	M29-039	M.E.P (lower limbs)	
VEMP	S48-164-8	Vestibular Evoked Myogenic Potential - cVEMP and oVEMP	

SNCV	M29-046	SNCV, hand	**俗稱NCV/EMG，通常兩個一起開** (除非老闆說不用扎針(EMG)) 上肢046+036+032+042+043 下肢047+037+033+042+043 上下肢一起就全開 (EMG會有個拋棄式針的自費耗材同意書)
	M29-047	SNCV, leg	
MNCV	M29-036	Nerve conduction velocity, upp	
	M29-037	Nerve conduction velocity, low	
F wave	M29-042	F wave	
H reflex	M29-043	H reflex	Blink reflex：facial palsy or GBS常開 RST：MG診斷
Blink reflex	M29-041	Blink reflex	
EMG	M29-031	EMG, facial	**請一定要寫診斷**(被咖掉就手寫) Neuropathy(GBS, CIDP), Myopathy, MG, Radiculopathy), (Plexopathy)….
	M29-032	EMG, hand	
	M29-033	EMG, leg	
RST	M29-044	Repetitive stimulation	

RST	M29-044	Repetitive stimulation	
SSR	M29-070	Sympathetic skin response	ANS survey，較少開
RRIV	M29-071	R-R interval variation study	
QTT	M29-057	Quantitative Thermal Threshold	
QST	M29-161	Quantitative Sweat Test (需自費)	
Tilting table	M22-110-8	Tilting table test	
Tremogram	M29-051	Tremogram	Movement team有時會開
	M29-052	Surface EMG	
EEG	M29-021	EEG, awake	EEG有兩種單：-021(awake)或-029(awake+sleep) 老闆沒特別說就開M29-029
24HR EEG	M29-030	Long-term physiological recording	
MMSE	M28-037-8	Psychophysiological functional Examination	病房不會開到
CDR	M28-021-8	Intelligence assement	
Holter	M22-018	EKG analyzer	心因性中風再考慮開
TTE	M22-060	Echocardiography with Doppler and color	

單位名稱	技術員	分機
肌電圖·神經傳導·		
1樓 (12號門)	玲幸	2218
1樓 (12號門)	琇絨	2218
1樓	鳳珠	2295
1樓 (11號門)	雲楨	2252
誘發電位		
SSEP/VEP/BAEP	芳茵	2247
SSEP/VEP/BAEP	子霞	2812
SSEP/VEP/BAEP	琪茱	2247
SSEP/MEP/BAEP	瑞珍	2271
SSR/RRIV/MEP	俐瑩	2209

單位名稱	技術員	分機
頸超		
10樓	淑卿	2359
11樓	碧霞	3917
門診區	惠敏	2251
腦波		
1樓	(輪替)	2740
10樓 / Portable	(輪替)	2240
10樓 / Portable	(輪替)	3943
11樓 (24HR VEEG)	(輪替)	3944

每日任務清單

- 關於檢查的那些事……
  - 神經科檢查代碼：M29-開頭。
  - 如屬於神經症急症(Cluster seizure, Gullain-Barre syndrome, Basilar artery occlusion)，開立檢查後請聯絡檢查室登記on call
- 一些閒雜的事情……
  - 教學門診：R1, PGY2, PGY1一個月一次
    Clerk一周1-2次
  - PGY/Clerk座談會：每月舉行一次，~~記得來吃便當~~
    老醫高齡團隊會議：每週一次，~~記得來吃便當~~
    11G、11H、13H護理站跨領域團隊會議：不定期任務，~~會有便當吃~~

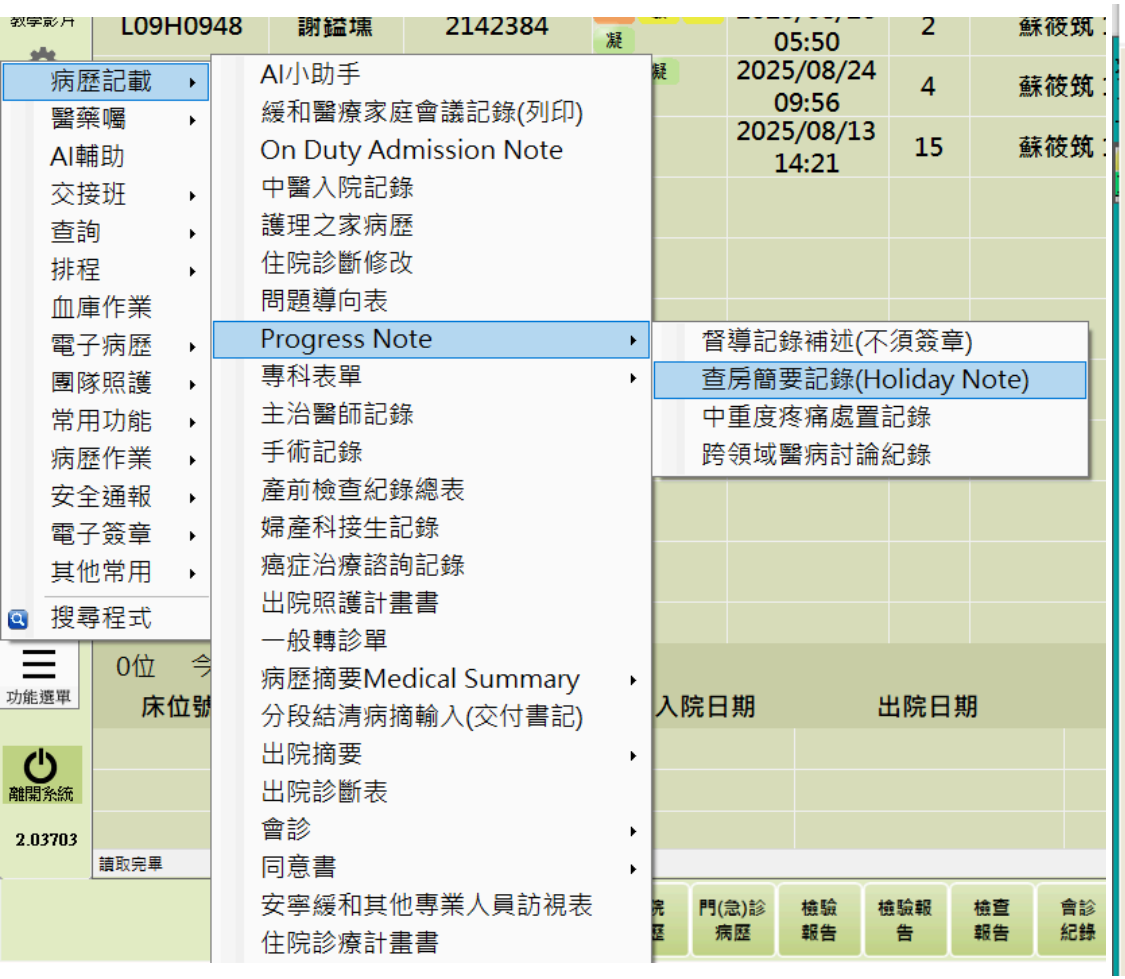
病房Cover規則

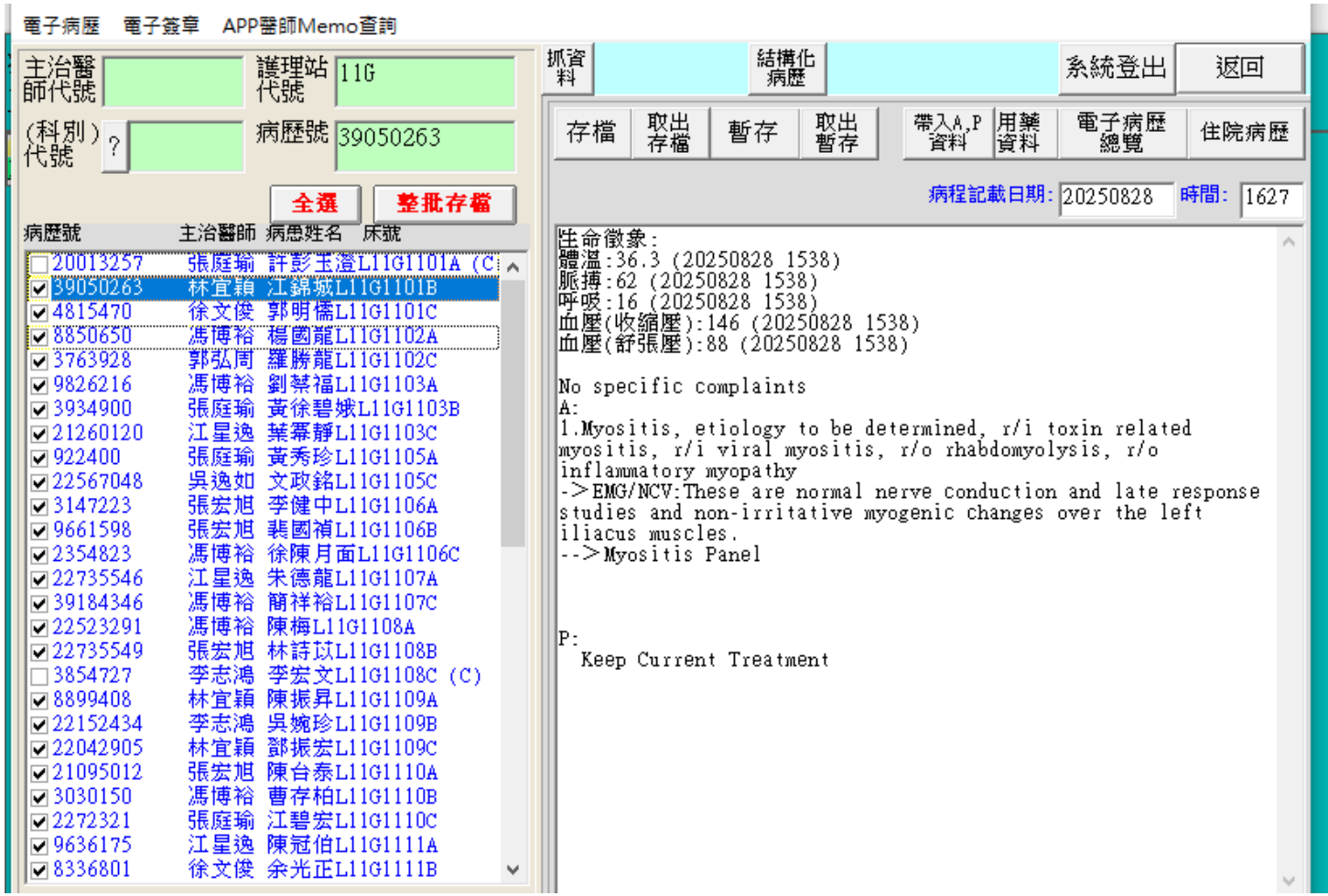
- 請參考Cover表，原則上同team互cover優先(老醫 or PGY/NP team)，部分狀況由senior R cover
- PGY值班隔天day off(原則上0800AM交班)，R值班隔天PM off(1200PM交班)
  - 如為day off/PM off，off的人須完成當天的progress note或weekly summary(可改前一天打)，並在下班前巡視過病人一輪後再交班(可於值班時間內抽空巡視)
  - 如為休假 cover，當天的Note由cover的人負責完成(如碰到W5請提早打或暫存weekly summary)

假日任務清單

- 交接班切**0800AM**
- 星期五、六或例假日前一晚值班醫師，需跟隔日的值班醫師口頭交班，包括critical case以及前一日新病人。
- 星期六、日、例假日會有假日查房，值班醫師需隨主治醫師查房，並簡報前一日住院病人病史及主要問題，建議查房前先簡單探視過病人。
- 星期六、日、例假日每位病人要點**holiday note**，注意是否有漏掉外圍的病人。

- 值班室位於復健大樓11樓(門牌：男生R1101、女生R1103)


L09H0948
謝鎰壎
2142384
05:50
2025/08/24 09:56
2025/08/13 14:21
蘇筱筑
病歷記載
醫藥囑
AI輔助
交接班
查詢
排程
血庫作業
電子病歷
團隊照護
常用功能
病歷作業
安全通報
電子簽章
其他常用
搜尋程式
AI小助手
緩和醫療家庭會議記錄(列印)
On Duty Admission Note
中醫入院記錄
護理之家病歷
住院診斷修改
問題導向表
Progress Note
專科表單
主治醫師記錄
手術記錄
產前檢查紀錄總表
婦產科接生記錄
癌症治療諮詢記錄
出院照護計畫書
一般轉診單
病歷摘要Medical Summary
分段結清病摘輸入(交付書記)
出院摘要
出院診斷表
會診
同意書
安寧緩和其他專業人員訪視表
住院診療計畫書
督導記錄補述(不須簽章)
查房簡要記錄(Holiday Note)
中重度疼痛處置記錄
跨領域醫病討論紀錄
0位
床位號
入院日期
出院日期
功能選單
離開系統
2.03703
讀取完畢
門(急)診病歷
檢驗報告
檢驗報告
檢查報告
會診紀錄


電子病歷
電子簽章
APP醫師Memo查詢
主治醫師代號
護理站代號
11G
(科別)代號
病歷號
39050263
全選
整批存檔
病歷號 主治醫師 病患姓名 床號
20013257 張庭瑜 許彭玉澄L11G1101A (C
39050263 林宜穎 江錦城L11G1101B
4815470 徐文俊 郭明儒L11G1101C
8850650 馮博裕 楊國龍L11G1102A
3763928 郭弘周 羅勝龍L11G1102C
9826216 馮博裕 劉禁福L11G1103A
3934900 張庭瑜 黃徐碧娥L11G1103B
21260120 江星逸 葉幕靜L11G1103C
922400 張庭瑜 黃秀珍L11G1105A
22567048 吳逸如 文政銘L11G1105C
3147223 張宏旭 李健中L11G1106A
9661598 張宏旭 裴國禎L11G1106B
2354823 馮博裕 徐陳月面L11G1106C
22735546 江星逸 朱德龍L11G1107A
39184346 馮博裕 簡祥裕L11G1107C
22523291 馮博裕 陳梅L11G1108A
22735549 張宏旭 林詩苡L11G1108B
3854727 李志鴻 李宏文L11G1108C (C)
8899408 林宜穎 陳振昇L11G1109A
22152434 李志鴻 吳婉珍L11G1109B
22042905 林宜穎 鄧振宏L11G1109C
21095012 張宏旭 陳台泰L11G1110A
3030150 馮博裕 曹存柏L11G1110B
2272321 張庭瑜 江碧宏L11G1110C
9636175 江星逸 陳冠伯L11G1111A
8336801 徐文俊 余光正L11G1111B
抓資料
結構化病歷
系統登出
返回
存檔
取出存檔
暫存
取出暫存
帶入A,P資料
用藥資料
電子病歷總覽
住院病歷
病程記載日期: 20250828
時間: 1627
生命徵象:
體溫:36.3 (20250828 1538)
脈搏:62 (20250828 1538)
呼吸:16 (20250828 1538)
血壓(收縮壓):146 (20250828 1538)
血壓(舒張壓):88 (20250828 1538)
No specific complaints
A:
1.Myositis, etiology to be determined, r/i toxin related myositis, r/i viral myositis, r/o rhabdomyolysis, r/o inflammatory myopathy
->EMG/NCV:These are normal nerve conduction and late response studies and non-irritative myogenic changes over the left iliacus muscles.
-->Myositis Panel
P:
Keep Current Treatment

常見注意事項


PD開打Hadol Q8H
MG開打Levofloxacin
V/C 8 沒抽過ABG
Cons Change
3天沒image
21天沒換的CVC
HF阿婆IV run 60
NRM 15L 沒DNR
Depakine +
Meropenem
這樣看起來危險嗎

日常常見問題

- *醫師XX床中風第X天了可以DC IV/DC FS / Vital sign 改routine嗎?*

- 中風病人入院範本是 V/S Q8H + IVF hydration + F/S四段
- 穩定期的病人可改routine(讓病人晚上睡覺) + DC IVF, F/S看狀況
- Cons差/MP還再down => 請keep Q8H
- 不確定 => 問VS

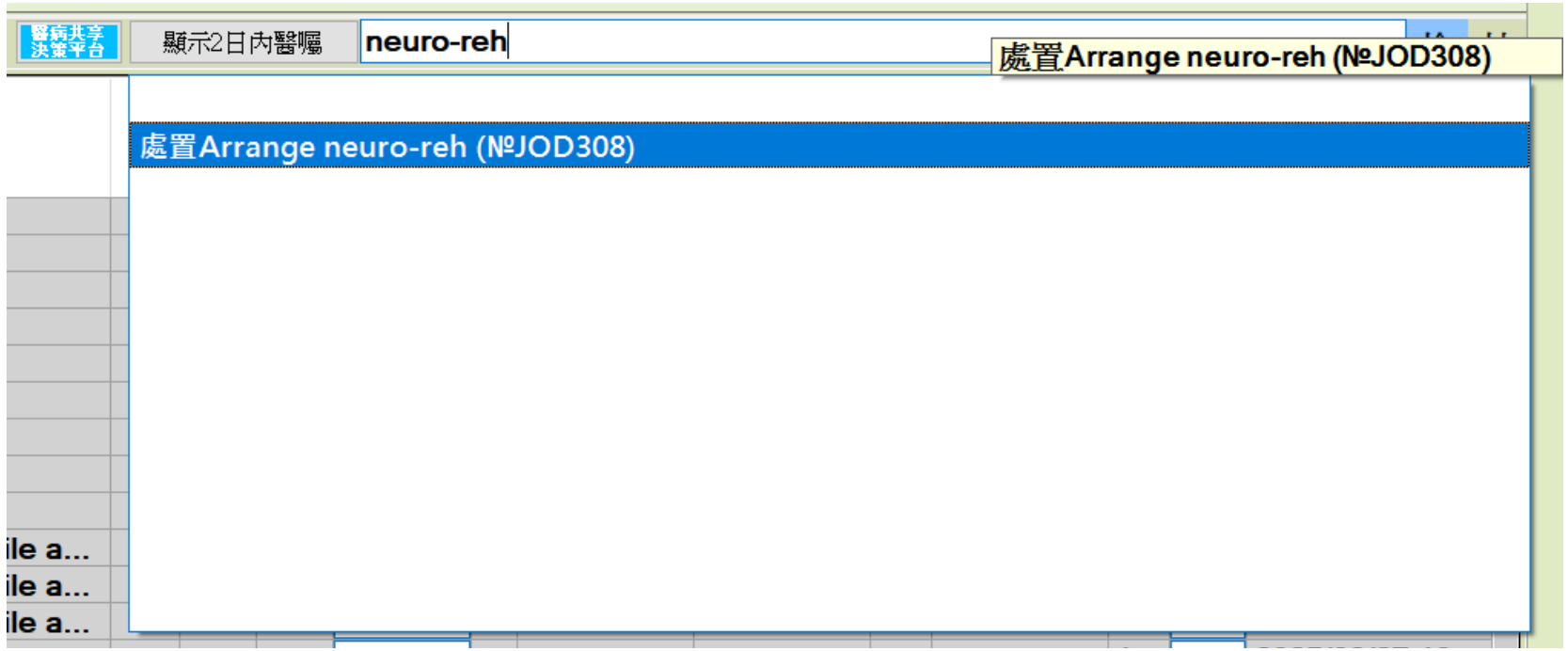


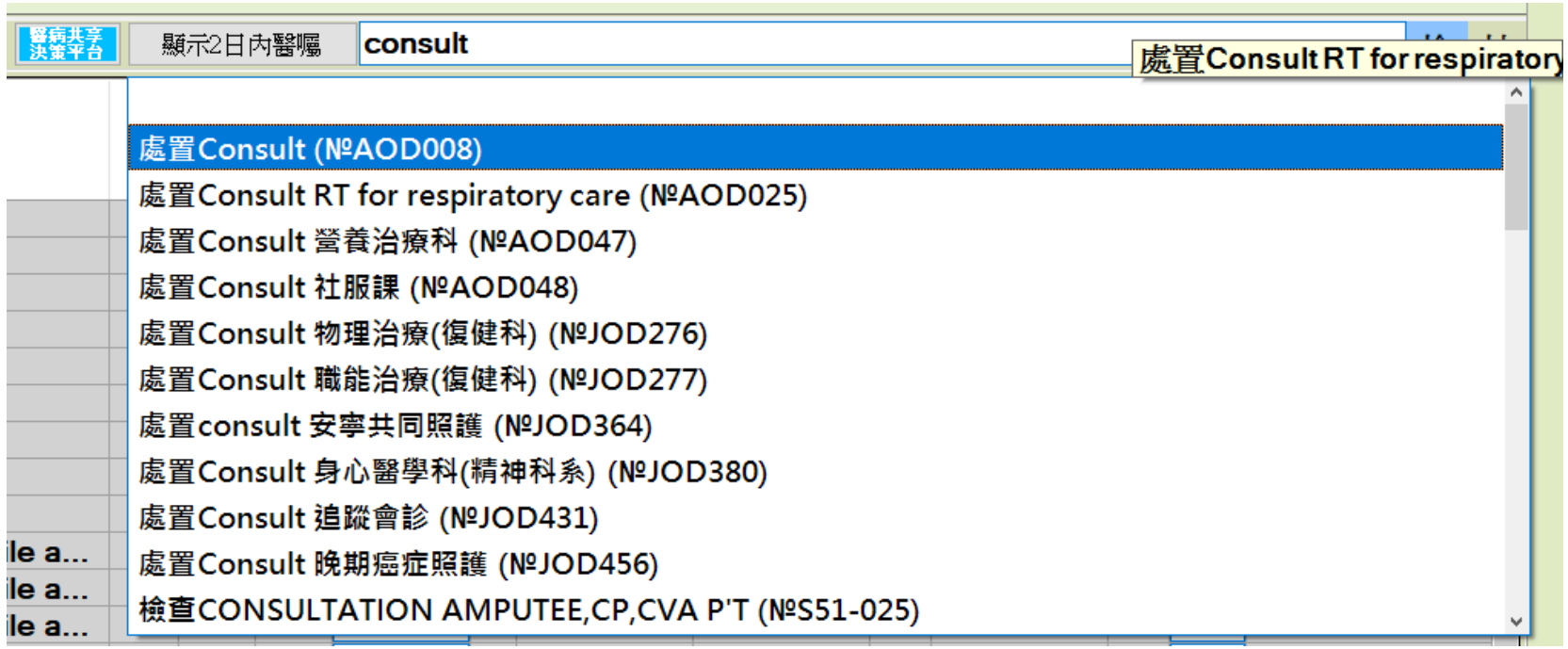
日常常見問題

- *醫師XX床中風第X天了有要幫他排復健嗎?*

- 本科復健泛指三種:
  - Neuro-rehab
  - 會診復健科排復健
  - PAC program

- 病患中風穩定可先開立neuro-reh, 復健老師會到bedside評估+指導
- 如果要去5H復健需經會診復健科開立復健單 + 排隊
- PAC program： 中高強度復健；腦中風患者(mRS 3-4分,可站or坐輪椅滑行)精神體力佳，請先聯繫PAC各管師評估(曾蕙雯GSM66340) 再會診復健科
  *簡單記: 能在床邊維持坐姿達半小時的病人 或許適合PAC


醫病共享決策平台
顯示2日內醫囑
neuro-reh
處置Arrange neuro-reh (№JOD308)
處置Arrange neuro-reh (№JOD308)


醫病共享決策平台
顯示2日內醫囑
consult
處置Consult RT for respiratory
處置Consult (№AOD008)
處置Consult RT for respiratory care (№AOD025)
處置Consult 營養治療科 (№AOD047)
處置Consult 社服課 (№AOD048)
處置Consult 物理治療(復健科) (№JOD276)
處置Consult 職能治療(復健科) (№JOD277)
處置consult 安寧共同照護 (№JOD364)
處置Consult 身心醫學科(精神科系) (№JOD380)
處置Consult 追蹤會診 (№JOD431)
處置Consult 晚期癌症照護 (№JOD456)
檢查CONSULTATION AMPUTEE,CP,CVA P'T (№S51-025)

日常常見問題

- *醫師病人Mannitol還要打嗎？I/O還要一直記嗎?*
- *醫師病人I/O XXOOXX.....*

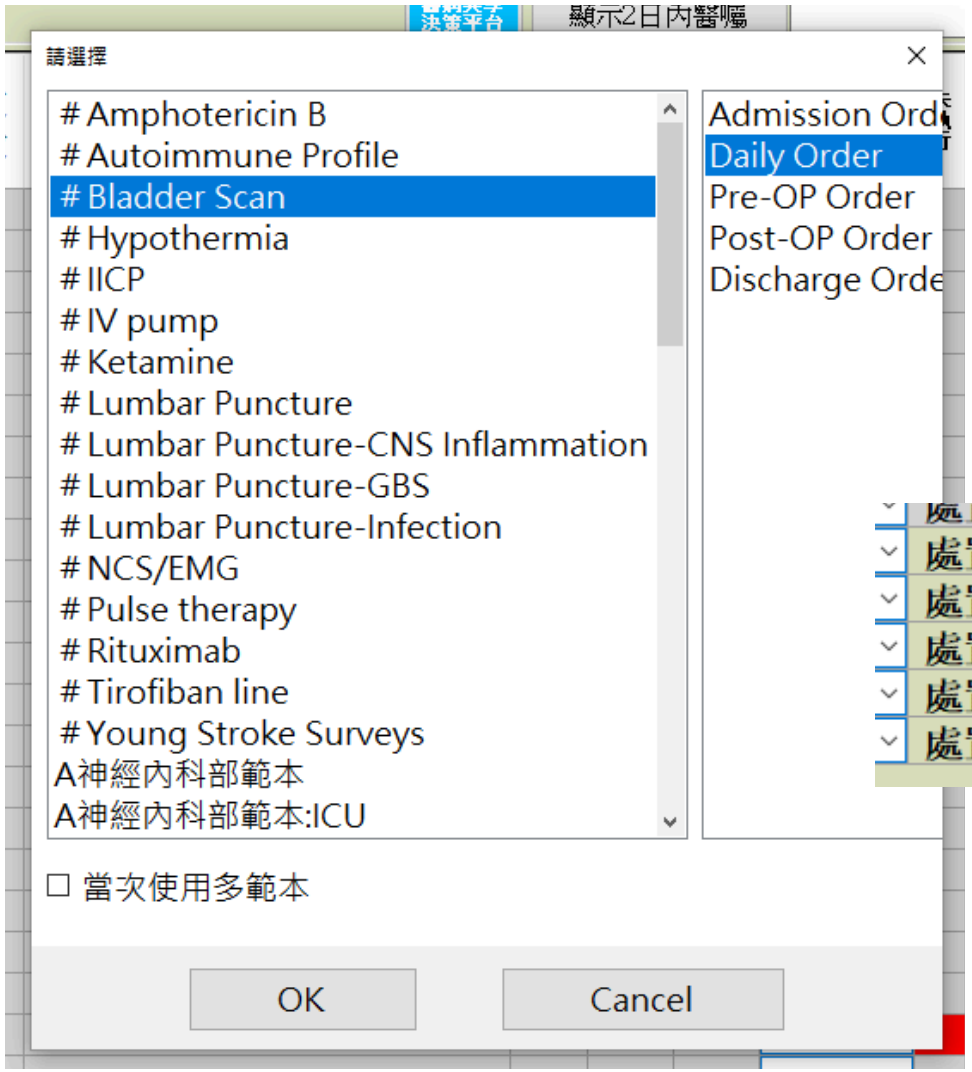
- 原則上有打Mannitol或Glycerol的病人我們都會記I/O
- Mannitol常用在Cerebral edema(中風或出血)的病人上控制腦腫，在病人穩定期時可以詢問主治醫師有無taper的計畫
  - 本科範本 #IICP → daily order 可參考相關用藥與開立方式
- 記得要看病人前一天I/O跟變化，注意不要dehydration跟fluid overload
- 有在用Mannitol跟Glycerol請定期追蹤腎功能

日常常見問題

- *醫師這床Foley到期你要try嗎還是re-on？ 要的話要開protocol*

- 神內病房拔foley的病人會有protocal(為了評鑑)
- 請大家要try自解的病人儘量前一天開立 CM Remove +
  - 避免在值班時間讓值班醫師re on Foley

- 值班早上的常見routine(請試著接受它)
  - 醫師XX床要re-on NG
  - 醫師XX床要拔Foley



處置	28	DC RESTRAINT		1	
處置	29	BLADDER SONOGRAPHY FOR ...		1	
處置	30	.		1	If RU＜100mL, check QD fo...
處置	31	.		1	If RU 100－200mL, check Q...
處置	32	.		1	If RU 201－300mL, check Q...
處置	33	.		1	If RU＞300mL, insert Foley ...

有問題的時候

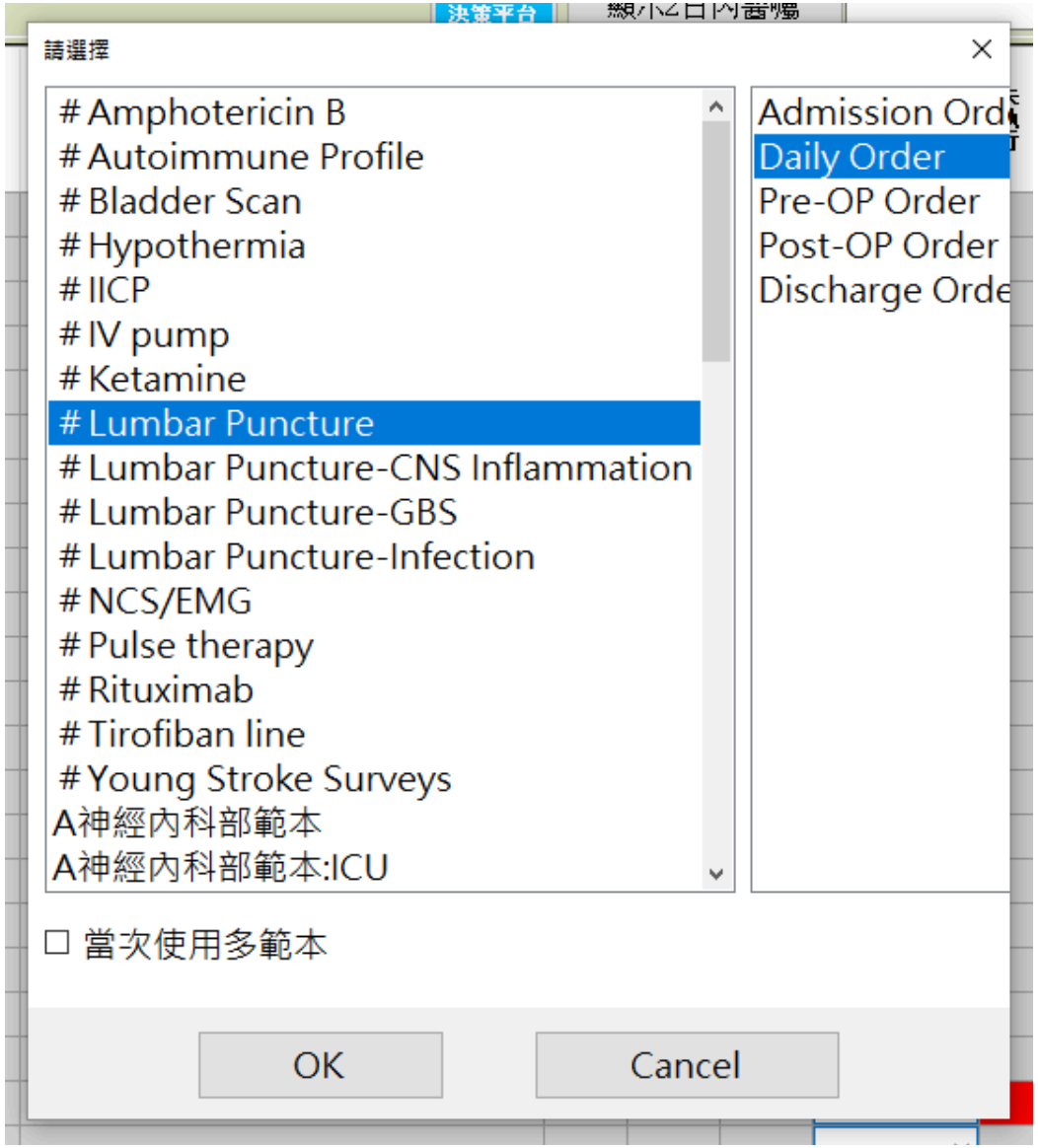
- 找Supervisor的時候：
  - Procedure cover (Lumbar puncture, CVC…)
  - 做完檢查(CT, EEG, NCV/EMG)需要協助判讀時
  - 覺得病人怪怪的時候

- 找CR的時候：
  - 覺得病人怪怪的時候
  - 需要訂ICU床的時候

- 值班的時候：
  - 找CE班(如CE班在看急會診可找I班學長姐協助)

有問題的時候

- 做腰椎穿刺檢查，請先確認brain image(CT or MRI)是正常的，抽血結果不可以有凝血功能問題
- 檢驗開單：請參考範本
- 開始留CSF前請務必測量壓力，結束後也要測壓，並記載到「Special Procedure Note」
- 護理師通常會問送檢體的順序。採集的前幾管容易因traumatic tapping而影響CSF routine和生化檢查，建議送後面幾管；送cytology的量要足夠可增加sensitivity。
- 做完後Bedrest至少1hr；如腦壓低可考慮IVF hydration 1-2天



醫囑 | 藥囑 | 病歷輸入

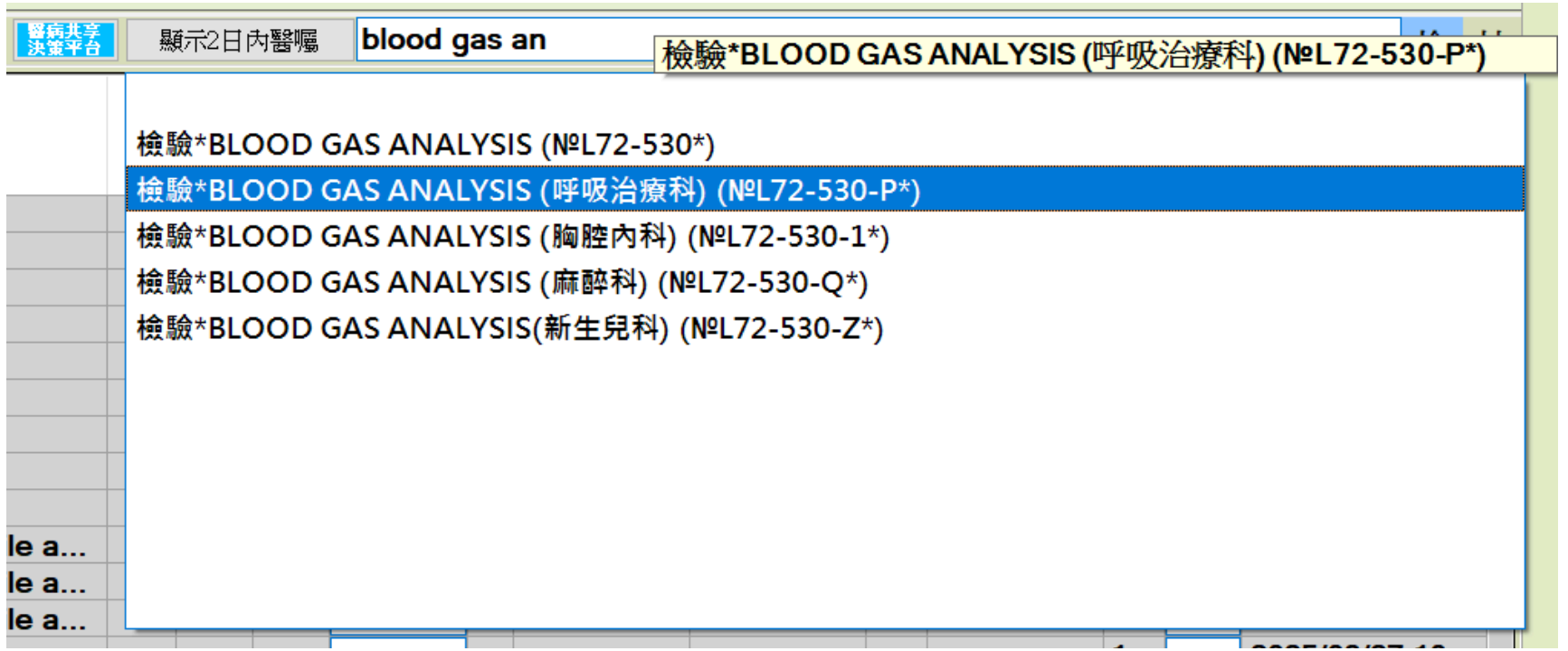
檢查/檢驗 Indication

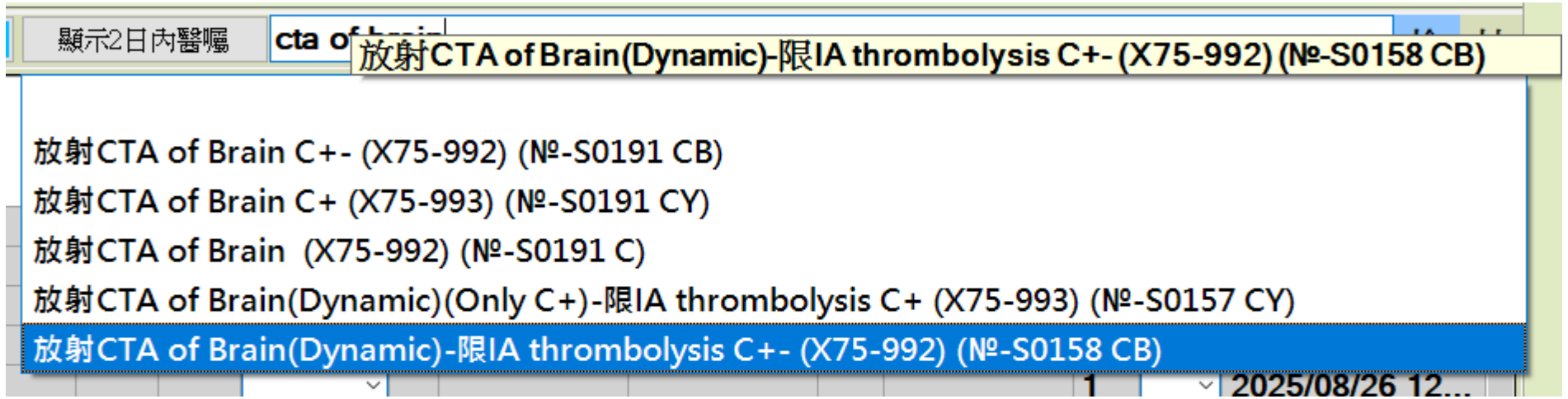
醫病共享決策平台 | 顯示2日內

刪除	狀態	類別	項次	名稱	急件	次數	備註	部位	檢體
X		處置	30	BED REST		1			-
X		檢驗	31	CSF ROUTINE		1			C...
X		檢驗	32	SUGAR STAT.	*	1			C...
X		檢驗	33	SUGAR STAT.	*	1			B
X		檢驗	34	MICROALBUMIN		1			C...
X		檢驗	35	ALBUMIN	*	1			B
X		檢驗	36	TOTAL PROTEIN(CSF)	*	1			C...
X		檢驗	37	LACTIC ACID (LACTATE)	*	1			C...
X		檢驗	38	GRAM STAIN		1			C...
X		檢驗	39	MYCOBACTERIAL SMEAR AND ...		1			C...
X		檢驗	40	FUNGUS CULTURE		1			C...
X		檢驗	41	COMMON AEROBIC CULTURE		1			C...
X		檢驗	42	INDIA INK STAIN		1			C...
X		檢查	43	FLUID CYTOLOGY-C.S.F.		1			C...
X		檢驗	44	CRYPTOCOCCUS ANTIGEN		1			C...
X		檢驗	45	CRYPTOCOCCUS ANTIGEN		1			B
X		檢驗	46	HERPES SIMPLEX VIRUS AB IGG		1			C...
X		檢驗	47	TB PCR		1			C...
X		檢驗	48	RPR/VDRL		1			C...
X		檢驗	49	IGG		1			C...
X		檢驗	50	IGG		1			B
X		檢驗	51	PROTEIN ELECTROPHORESIS		1			C...
X		檢驗	52	PROTEIN ELECTROPHORESIS		1			B
X		檢驗	53	IMMUNOFIXATION ELECTROPH...		1			C...
X		檢驗	54	IMMUNOFIXATION ELECTROPH...		1			B
X		檢驗	55	Meningitis Encephalitis multiplex ...		1			C...
X		處置	56			1	預留2等		-

爛掉的時候

- Acute conscious change / new onset seizure
  - Check F/S, complete metabolic survey (ABG, 離子(Na Ca Mg), 感染(CRP, PCT), Lactate, Ketone, Ammonia, (cortisol), (thyroid)……)
  - Check pupil, EOM(VOR)
  - 檢查一下近期用藥(鎮靜藥? 肌鬆? Anti-psychotic?)
  - 排檢查(尤其CTA)之前可先跟上線討論
- Stroke in evolution (MP down, speech arrest…etc)
  - Check F/S, 確定onset time (問病人, 家屬, 護理師…..)
  - Check new neurological deficit (compared with baseline)
  - 有出血可能就先排C- CT of brain; 懷疑大血管阻塞請和上線討論是否需做CTA+P
- CTA + P單： CTA of brain(Dynamic) – 限IA thrombolysis C+-


醫病共享決策平台
顯示2日內醫囑
blood gas an
檢驗*BLOOD GAS ANALYSIS (呼吸治療科) (№L72-530-P*)
檢驗*BLOOD GAS ANALYSIS (№L72-530*)
檢驗*BLOOD GAS ANALYSIS (呼吸治療科) (№L72-530-P*)
檢驗*BLOOD GAS ANALYSIS (胸腔內科) (№L72-530-1*)
檢驗*BLOOD GAS ANALYSIS (麻醉科) (№L72-530-Q*)
檢驗*BLOOD GAS ANALYSIS(新生兒科) (№L72-530-Z*)
le a...
le a...
le a...

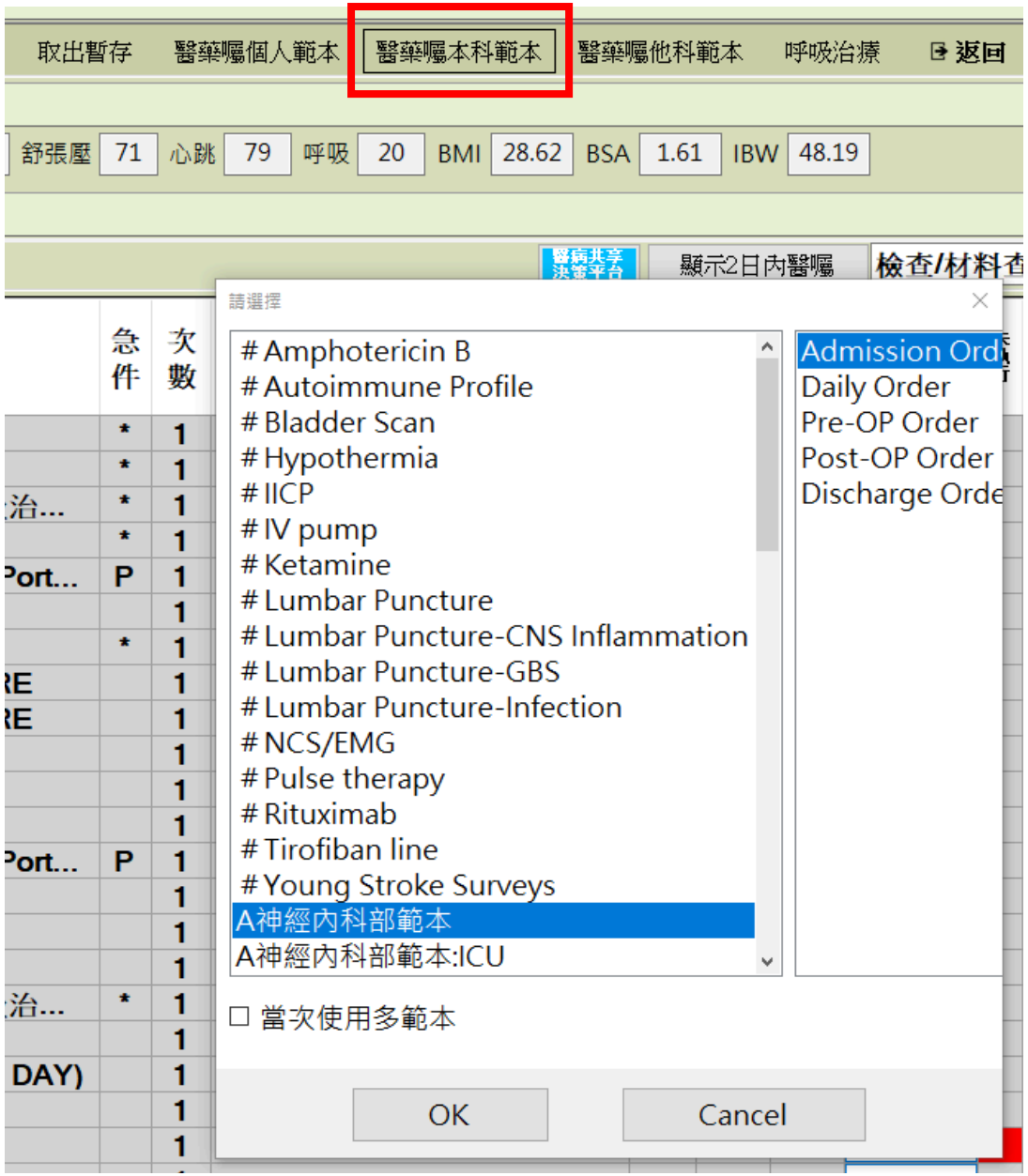

顯示2日內醫囑
cta of
放射CTA of Brain(Dynamic)-限IA thrombolysis C+- (X75-992) (№-S0158 CB)
放射CTA of Brain C+- (X75-992) (№-S0191 CB)
放射CTA of Brain C+ (X75-993) (№-S0191 CY)
放射CTA of Brain (X75-992) (№-S0191 C)
放射CTA of Brain(Dynamic)(Only C+)-限IA thrombolysis C+ (X75-993) (№-S0157 CY)
放射CTA of Brain(Dynamic)-限IA thrombolysis C+- (X75-992) (№-S0158 CB)
1
2025/08/26 12...

各科常見問題



腦血管科

- 開立入院醫囑時，可使用腦血管科醫囑範
  - 內含 Vital sign Q8H, F/S, IVF 60 ml/hr(請根據病人狀況調整!!!),
  - 給IVF 請只給Normal saline
- BP control目標:
  - Ischemic stroke – BP < 220/120 mmHg
    Ischemic stroke(s/p tPA) – BP < 180/105 mmHg
    Ischemic stroke(s/p IA) – BP < 140/90 mmHg (if TICI 2b-3)
    Hemorrhage stroke - BP < 140/90 mmHg
  - 若病人血壓微高可優先考慮Labetalol 0.5-1PC PO prn或
    Captopril 1PC PO Q6H prn
  - 血壓非常高可上Nicardipine line: 10PC in N/S 100ml run 6 ml/hr +/- 2 ml/hr
    - 本科範本 #IV pump → daily order 可參考相關用藥開立方式
  - 使用血壓藥前請注意相關禁忌症；儘量避免短效型nifedipine





刪除	狀態	類別	項次	名稱	急件	次數	備註	部位	檢體
X		處置	29	ADMISSION ORDER:		1			-
X		處置	30	ON THE SERVICE OF DR.		1			-
X		處置	31	DIAGNOSIS(1):		1			-
X		處置	32	DIAGNOSIS(2):		1			-
X		處置	33	DIAGNOSIS(3):		1			-
X		處置	34	DIAGNOSIS(4):		1			-
X		處置	35	DIAGNOSIS(5):		1			-
X		處置	36	DIAGNOSIS(6):		1			-
X		處置	37	CONDITION: GUARDED		1			-
X		處置	38	ALLERGY:		1	No known allergy		-
X		處置	39	ACTIVITY:AS TOLERATED IN R...		1			-
X		處置	40	DIET AS TOLERABLE		1			-
X		處置	41	.		1	Record 身高、體重、腰圍...		-
X		處置	42	.		1	Record NIHSS, mRS, BI on...		-
X		處置	43	VITAL SIGNS AND GCS:Q8H		1			-
X		處置	44	IVF		1	N/S run 60mL/hr		-
X		處置	45	CHECK BLOOD AC AND PC SUG...		1			-
X		處置	46	CHECK BLOOD AC,PC,3PM,9PM...		1			-
X		處置	47	ON SUCTION(DAY)		1	PRN		-
X		處置	48	病人嚴重度分級:C級		1			-
X		處置	49	病人嚴重度分級:D級		1			-
X		處置	50	**		1			-
X		檢驗	51	SUGAR A. C.		1			B
X		檢驗	52	GLYCOHEMOGLOBIN		1			B
X		檢驗	53	DM LIPID PROFILE（TG,CHOL,H...		1			B
X		檢驗	54	URINE ROUTINE EXAMINATION	*	1			U
X		檢驗	55	SEDIMENTS	*	1			U

腦血管科

- 常見檢查：TCD/CCD (M29-079 + M29-088)
- 有懷疑Cardio-embolic stroke才需開立 2D-echo + Holter
- MRA(C+/-)：
  - 因MRA排程通常較久，接病人時如覺得需要可開立 *“等當科VS決定再簽同意書”*，如不確定就先不開立
  - 如需使用鎮靜藥物，請和主治醫師討論需要用何種藥物及藥物劑量，盡量避免於值班時段排定需要鎮靜的MRI
  - 如是緊急狀況或特殊狀況，請與值班醫師交班藥物使用
- 務必於住院的第一天告知家屬，任何的腦中風於發生後一週內皆有可能再惡化，請照顧的家屬要特別留意病人的意識狀態、肢體力量有無變差或其他的症狀出現

腦血管科

- **Stroke in Evolution**
  - **確定NE變化**(e.g. MP掉多少)，如果可以最好直接評估NIHSS score
  - 請立即確認是否有內科問題（呼吸衰竭、低血壓、電解質不平衡、低血糖、脫水、貧血、感染症、藥物影響…）
  - 若非歸因於上述問題，請聯絡CT room 急做 non-contrast CT of brain (白天：2樓復健 2403-3789；值班：急診CT room 2403-2568)
  - 可跟上線討論是否需做CTA
- Life Threatening Stroke Syndrome
  - Large MCA/ACA territory infarcts
  - Basilar artery occlusion
  - Large cerebral hemorrhage、 pontine hemorrhage、 cerebellar hemorrhage
  - 以上的腦血管疾病隨時會危及生命，狀況不穩時請告知Supervisor/CR 並記得交班

腦血管科

- 入院做Angiography的病人
  - 如為預計給影像科做的 => 開Angiography of brain
  - 如為腦血管科醫師(如張健宏)簽住院入刀房做的 => 手術醫師會自己開order
  - 做Angio 3天內要check PT, aPTT, platelet, Cr, BUN，看有沒有最近的EKG, CXR，術前後IVF hydration 1天

腦血管科

- 中風急性期需要特別注意的用藥:
- **安眠藥**:
  - 中風急性期避免使用安眠鎮靜藥，以免影響醫護人員評估意識
  - BZD: Alprazolam, Fludiazepam, Lorazepam, Estazolam等,
    Antipsychotics: Quetiapine, Chlorpromazine, Haloperidol
- **肌肉鬆弛劑**
  - 中風急性期一律禁止使用肌肉鬆弛劑，以免影響醫護人員評估肌力
  - Carisoprodol, Baclofen, Methocarbamol, Tizanidine, Chlorzoxazone
- **抗膽鹼藥物**
  - 非必要請避免給予抗膽鹼藥物，避免造成病人意識變差
  - Antihistamine類的Vena,

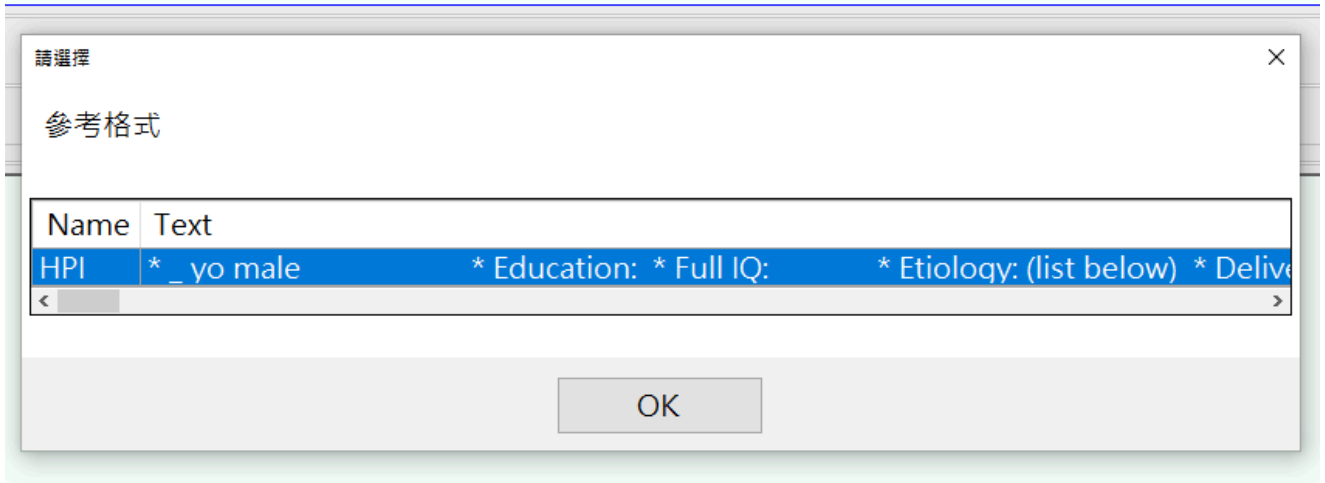
腦血管科

- 如果病人同時使用PPI和**plavix**, 請避免合併使用Esomeprazole，因為它會降低plavix的效果。可以選用其他PPI像是Lansoprazole, Pantoprazole。
- 非必要的話PPI也不要長期使用 (>8wk)，會造成Risk of C. difficile infection, pneumonia, GI malignancies, bone loss, and fractures，影響B12吸收會造成Cognitive decline。

癲癇科

- 如新病人入院診斷為初次發作之seizure/epilepsy，請早上聯絡EEG room(2240 or 3943)告知技術員為Seizure case，請檢查室登記on call
  - 癲癇頻繁發作須插做亦同
- Seizure病人問診：記得要問ASM hx, aura, semiology, post-ictal phase
  - 可參考科範本：


請選擇
請選擇一個項目
科範本
個人範本
他科範本
請選擇一個項目
A神經內科部範本
A神經內科部範本:ICU
B IV-tPA
B Post-IA
B Post-IV-tPA
B失智症科範本
B神經肌肉科範本
B動作障礙科範本
B腦血管科範本
B癲癇科範本
Amphotericin B
Autoimmune Profile
OK
關閉


請選擇
參考格式
Name
Text
HPI
* _ yo male
* Education:
* Full IQ:
* Etiology: (list below)
OK


* Education:
* Etiology: (list below)

癲癇科

- 如需檢驗藥物濃度：
  - Valproate (Deparkin) => 請驗Free Valproic acid (L72-121)
  - 其他癲癇藥物 => TDM of antiepileptic drugs by LC-MS/MS (L72-440A)
    - 第一張單子只能點一種藥物，第二張單子不限
    - 此檢查為自費項目，一種藥物1400元，兩種以上均為2800元
- 門診簽 Video EEG (24-hour EEG) 的病人：
  - 目前檢查單由VS自行開立
  - 請注意「門診紀錄」或「住院通知單」中，有無註明藥物減量
    一般檢查結束當天把病人的藥物恢復原劑量，再辦理出院。
  - 如果是住院要加做，請：1.確定VS要找哪位醫師打vEEG報告
    2.跟病人家屬解釋需有部分負擔(1天2000元) + 需24小時家屬陪同
    3.跟vEEG room(11G)技術員登記床位，有床位後找書記佔床+轉床

癲癇科

- 常見的ASMs
  - Levetiractam(Keppra)：注意renal dose, 1000~3000mg/day
  - Valproic acid(Depakin)：注意肝毒性+Ammonia, thrombocytopenia, 1200~2400mg/day
  - Lacosamide：注意AV block, 100mg~400mg/day
  - 新加上的ASM記得要Loading
- Seizure病人用藥注意事項：
  - 常見副作用：Carbamazepine/Oxacabazepine - SJS/ TENS
    Levetiractam – Psychosis；Valproic acid – Liver
    Topiramate – Speech arrest；Lacosamide: PR prolong, PVC
  - 盡量避免會誘發癲癇的抗生素，像是Carbapenam類，Cefepime等
  - Depakine不和NOAC併用(可能增加出血風險)；不和Meropenem併用(濃度=0)；懷孕婦女禁用(會致畸胎)

神經肌肉疾病科

- Motor neuron disease、 myasthenia gravis、 Gullain-Barre syndrome、 high cervical spinal cord insult的病人常會造成呼吸衰竭，務必於住院的第一時間測量Vital capacity (呼吸治療醫囑開立ONCE & Q12H/QD)
  - 若Vital capacity 小於 15-20ml/kg，請check ABG；若有CO2 retention請立即Call for Help!
  - 這類病人務必避免使用呼吸抑制藥物(BZD, Muscle relaxant等)

神經肌肉疾病科

- 開立NCV/EMG
  - 若不清楚要開立何項檢查，請先詢問主治醫師
  - 檢查單上請務必註明病人的診斷，例如：polyneuropathy、myopathy、radiculopathy、radial neuropathy、dermatomyositis…
  - 若病人需做repetitive stimulation (RST)，除了臨床診斷外，請額外註明低頻或高頻 (3 Hz for myasthenia gravis；50Hz for Lambert-Eaton,myasthenic syndrome)
- Myasthenia gravis的病人避免使用
  - Aminoglycoside (amikacin, gentamicin),
  - Fluoroquinolone (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin),
  - Macrolides (azithromycin, clarithromycin, erythromycin)
  - Beta-blockers

動作障礙科

- 門診住院的病人，除非主治醫師有在住院通知單上特別說明，否則藥物照門診藥物使用。
  - 病人服藥的方法，不能只看門診記錄，許多病人服藥頻次特殊，需直接向病人詢問之
- Parkinsonism病人需要注意
  - 禁止使用Haloperidol, 以免造成Neuroleptic malignant syndrome
  - 避免使用anti-emetics像是primperan, novamin，如要使用可以考慮domperidone